

Reporte Automatizado de Circulación Viral



Alcalde Mayor de Bogotá
Carlos Fernando Galán Pachón

Secretario Distrital de Salud
Gerson Orlando Bermont Galavis

Subsecretario de Salud Pública
Manuel Alfredo González Mayorga

Coordinación general del documento

Directora de Epidemiología, Análisis y Gestión de
Políticas de Salud Colectiva
Diane Moyano Romero

Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública
Sol Yiber Beltran Aguilera

Autor

Laboratorio de Salud Pública
Sandra Liliana Gómez Bautista
Paula Andrea Borda Osuna

Coordinación Editorial

Oficina Asesora de Comunicaciones en Salud
María Juliana Silva Amado

Corrección de estilo
José Aldemar Garzón González

Diseño y diagramación
Harol Giovanni León Niampira

Fotografía portada
www.saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud
Carrera 32 No. 12-81
Conmutador: 364 9090
Bogotá, D. C. - 2024
www.saludcapital.gov.co

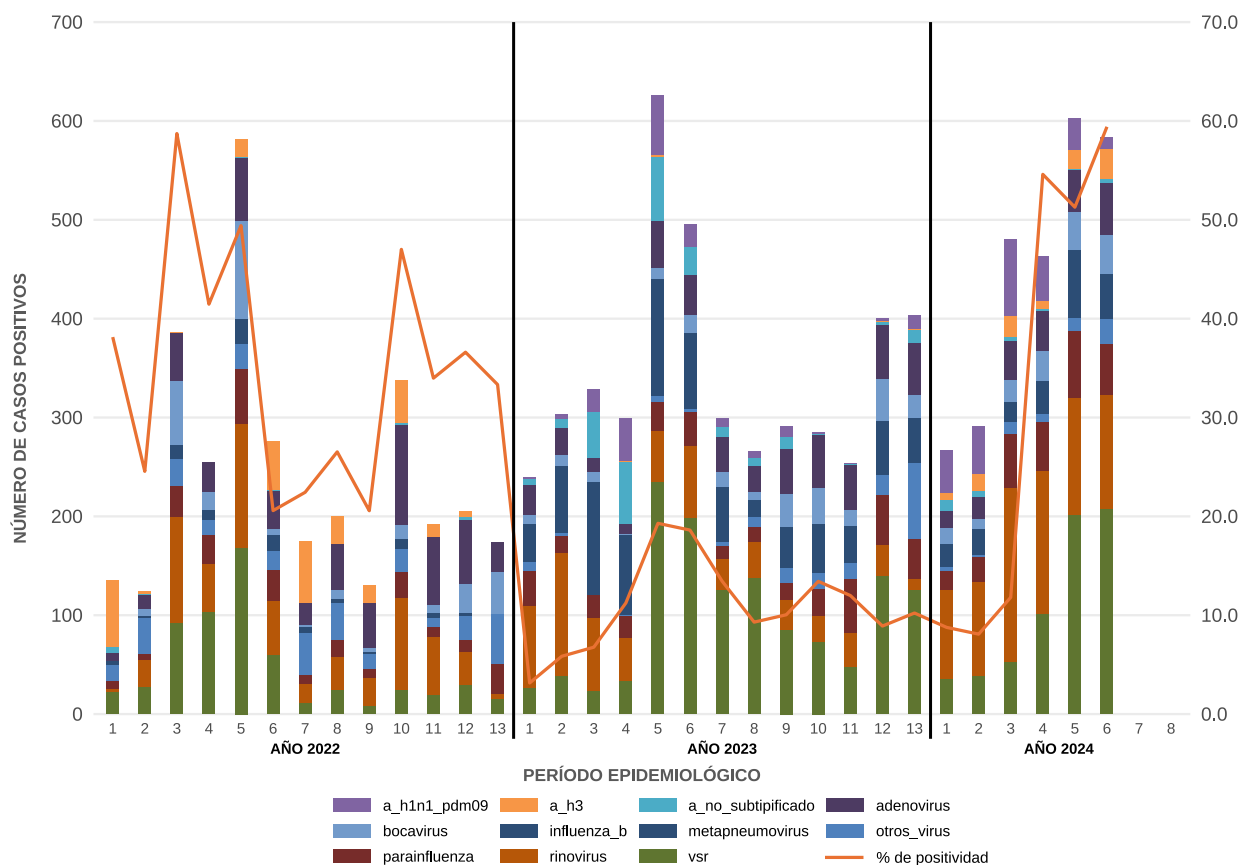
1 Virus respiratorios

Durante 2025, el Laboratorio de Salud Pública (LSP) continúa apoyando la vigilancia de la infección respiratoria aguda en Bogotá, mediante el procesamiento de muestras remitidas por instituciones centinela de los eventos: Enfermedad Similar a Influenza (ESI) que son pacientes ambulatorios, de pacientes hospitalizados por Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) y de IRAG inusitado que se presente en cualquier institución de la ciudad.

Las muestras previamente son procesadas por RT-PCR para SARS-CoV-2 y después continúan su análisis con: panel respiratorio Allplex y reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) para el diagnóstico de los principales agentes a los que se les atribuye el IRAG.

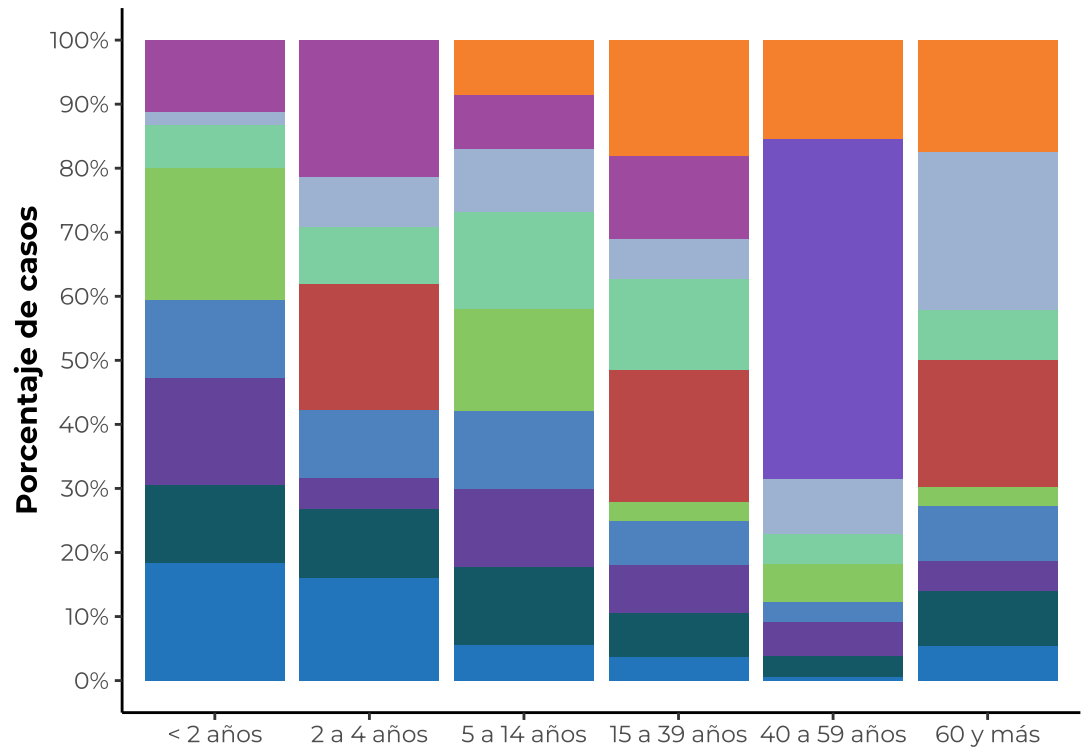
En el análisis del comportamiento de los virus respiratorios por periodo epidemiológico desde el 2022 se observa que se ha mantenido la circulación de virus como Rinovirus, Adenovirus y VSR. Para los tres años entre los periodos 3 al 6 coincide con el pico respiratorio que se presenta en todos los años (Figura 1).

Figura 1: Circulación de virus respiratorios por período epidemiológico Año 2022 - 2024, Laboratorio de Salud Pública Bogotá.



Para esta semana, por grupo de edad, el 46.5% de pacientes positivos para virus respiratorios diferentes al SARS-CoV-2 en 2025 corresponden a la población de menores de 5 años (figura 2) y si se incluye al SARS-CoV-2 los menores corresponden al 37.5 % (figura 3).

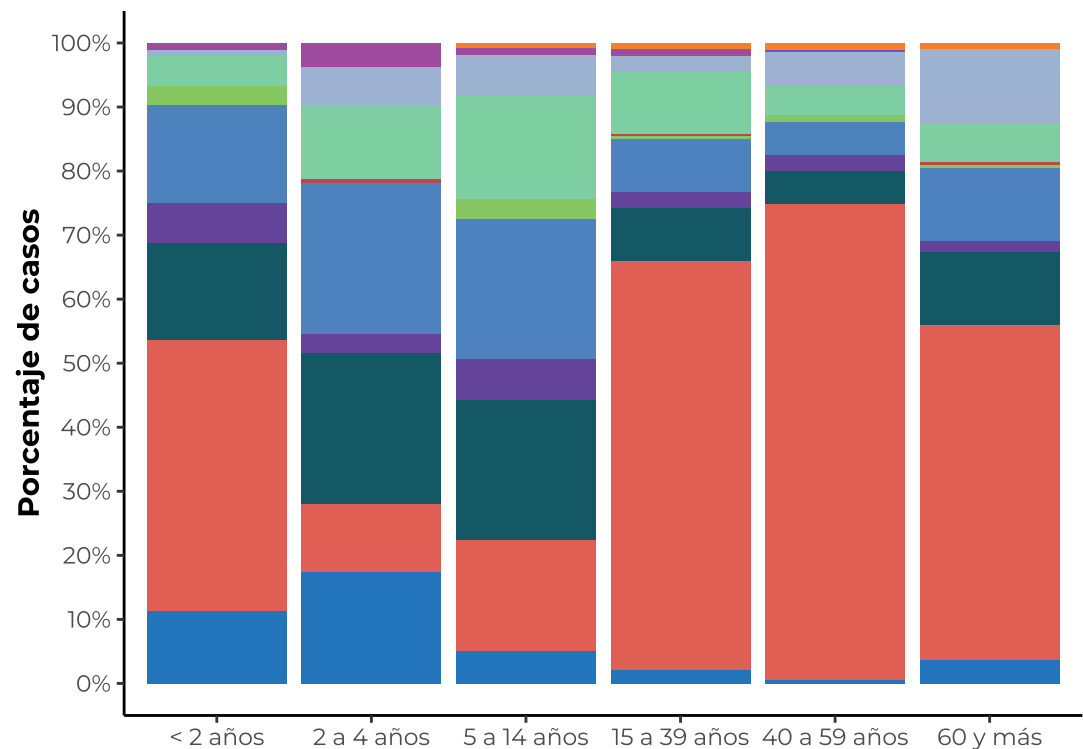
Figura 2: Distribución porcentual de virus respiratorios por grupo de edad, Laboratorio de Salud Pública Bogotá.



A no subtipificado		0	0	1	2	2
Adenovirus		4	5	2	3	0
Bocavirus		0	0	0	0	0
H1N1		0	0	0	0	1
H1N1 2009		3	8	10	6	10
H3N2		17	15	25	23	9
Influenza B		0	1	0	1	0
Metapneumovirus		10	0	5	1	2
Otros Virus		54	31	34	20	10
Parainfluenza		22	4	10	6	5
Rinovirus		54	31	34	20	10
VSR		40	23	8	5	1

En la figura 3 se presenta el consolidado de los virus respiratorios por los diferentes grupos de edad, en los niños menores de 2 años las mayores frecuencias son de casos de Metapneumovirus (53 %), VSR (47 %) y Parainfluenza (43 %), para los niños entre 2 y 4 años se presentan casos de Adenovirus (36 %), Influenza B (33 %) y VSR (27 %).

Figura 3: Distribución porcentual de virus respiratorios y SARS-CoV-2 por grupo de edad, Laboratorio de Salud Pública Bogotá.

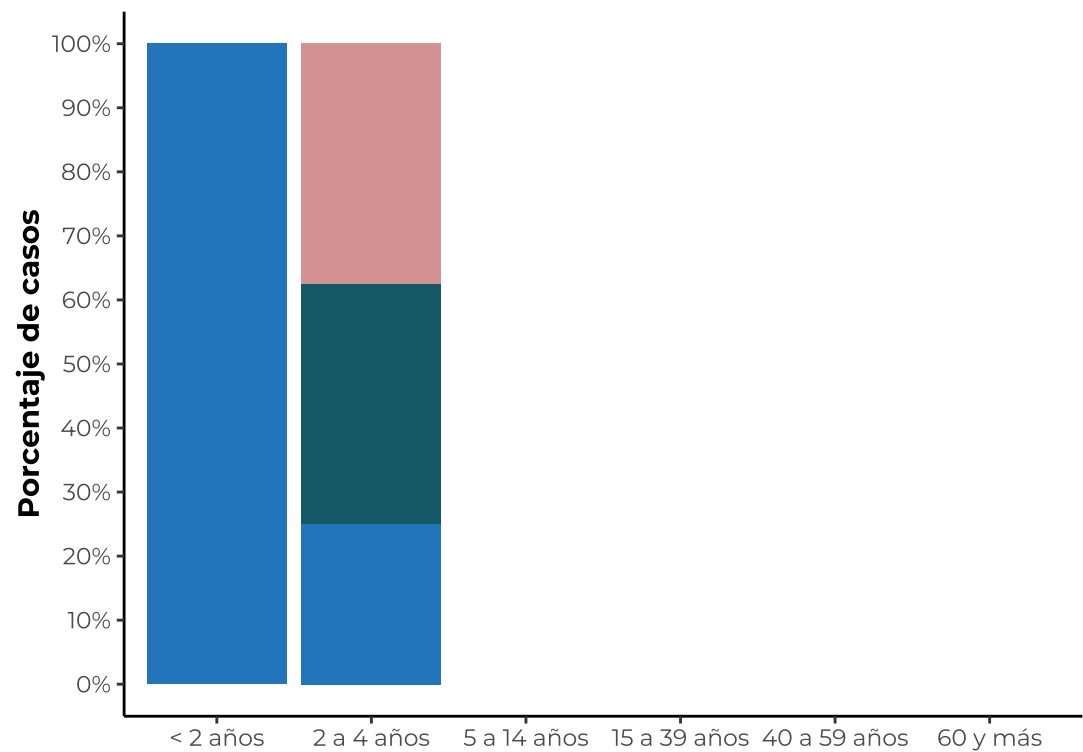


A no subtipificado		0	0	1	2	2	2
Adenovirus		4	5	2	3	0	0
Bocavirus		0	0	0	0	0	0
H1N1		0	0	0	0	1	0
H1N1 2009		3	8	10	6	10	26
H3N2		17	15	25	23	9	13
Influenza B		0	1	0	1	0	1
Metapneumovirus		10	0	5	1	2	1
Otros Virus		54	31	34	20	10	25
Parainfluenza		22	4	10	6	5	4
Rinovirus		54	31	34	20	10	25
SARS CoV 2		149	14	27	153	144	115
VSR		40	23	8	5	1	8

Al incluir el virus de SARS-CoV-2 en la cuenta de los virus respiratorios, se observa que, en los menores de 2 años años las frecuencias son para Metapneumovirus (53 %), VSR (47 %) y Parainfluenza (43 %), en el grupo de 2 a 4 años, Adenovirus (36 %), Influenza B (33 %) y VSR (27 %). A continuación, se presenta la circulación acumulada de los virus respiratorios de forma desagregada por tipo de vigilancia, según grupo de edad (figura 4). También se ha incluido al SARS-CoV-2.

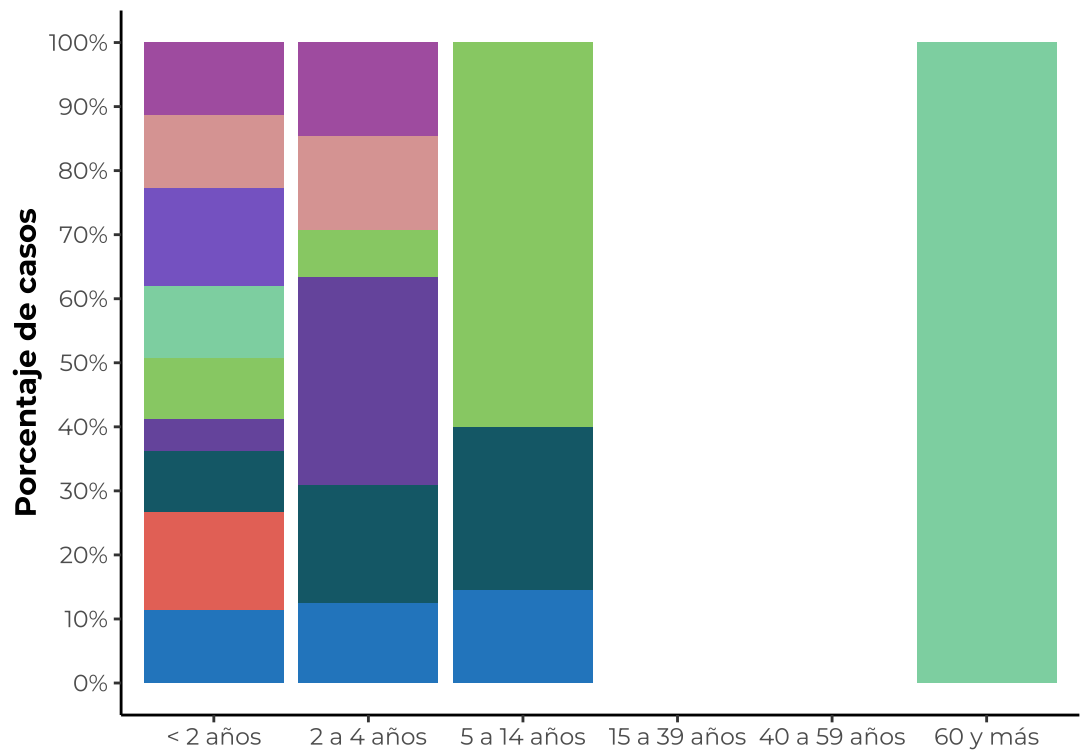
Figura 4: Circulación de virus respiratorios por tipo de vigilancia y según grupo de edad, Laboratorio de Salud Pública.

Distribución de virus respiratorios en casos de ESI, según grupos de edad.



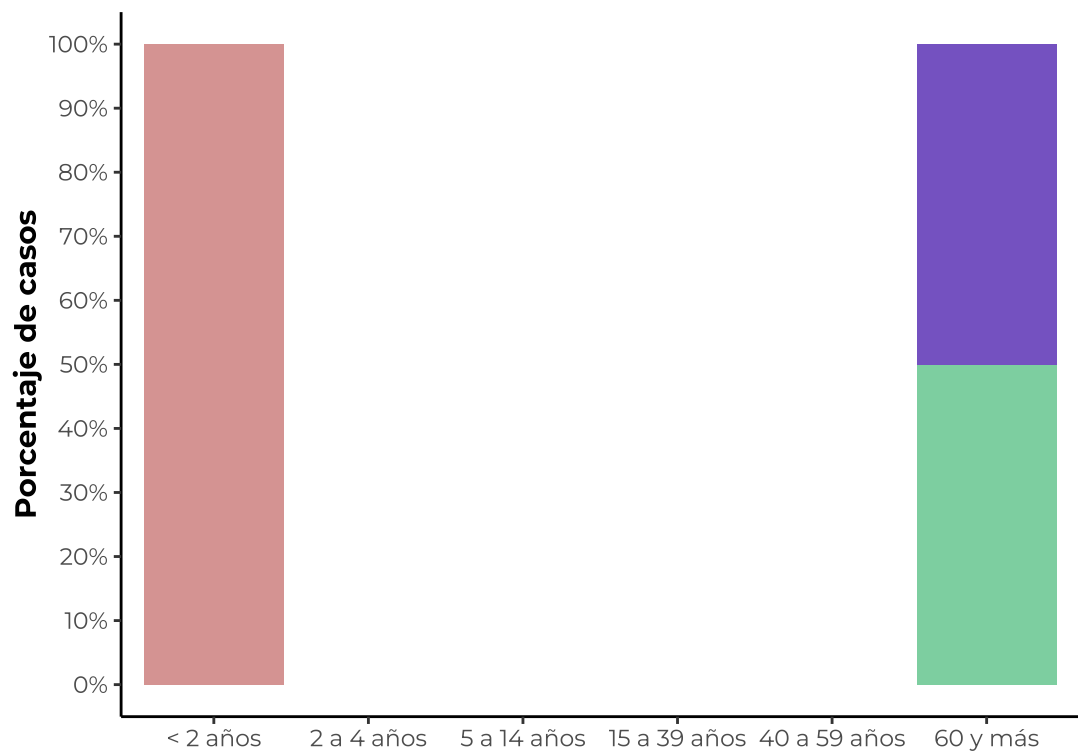
Adenovirus		0	0	0	0	0	0
Bocavirus		0	1	0	0	0	0
H1N1		0	0	0	0	0	0
H3N2		0	0	0	0	0	0
Influenza B		0	0	0	0	0	0
Metapneumovirus		0	0	0	0	0	0
Parainfluenza		0	0	0	0	0	0
Rinovirus		0	1	0	0	0	0
SARS CoV 2		0	0	0	0	0	0
VSR		1	2	0	0	0	0

Distribución de virus respiratorios en casos de IRA Grave, según grupos de edad



Adenovirus		6	2	0	0	0	0
Bocavirus		6	2	0	0	0	0
H1N1		3	0	0	0	0	0
H3N2		3	0	0	0	0	1
Influenza B		0	0	0	0	0	0
Metapneumovirus		5	1	1	0	0	0
Parainfluenza		3	5	0	0	0	0
Rinovirus		12	6	1	0	0	0
SARS CoV 2		1	0	0	0	0	0
VSR		25	7	1	0	0	0

Distribución de virus respiratorios en casos de IRAG Inusitado, según grupos de edad.



Adenovirus		0	0	0	0	0	0
Bocavirus		1	0	0	0	0	0
H1N1		0	0	0	0	0	1
H3N2		0	0	0	0	0	1
Influenza B		0	0	0	0	0	0
Metapneumovirus		0	0	0	0	0	0
Parainfluenza		0	0	0	0	0	0
Rinovirus		0	0	0	0	0	0
SARS CoV 2		0	0	0	0	0	0
VSR		0	0	0	0	0	0

En la figura 5 se puede observar el comportamiento de los virus identificados tanto por la vigilancia centinela como por la vigilancia del IRAG inusitado, mediante las dos metodologías: panel respiratorio Allplex y RT-PCR.

En las semanas transcurridas de 2025 se aprecia la positividad para cualquier virus respiratorio, diferentes al SARS-CoV-2, en la siguiente tabla.

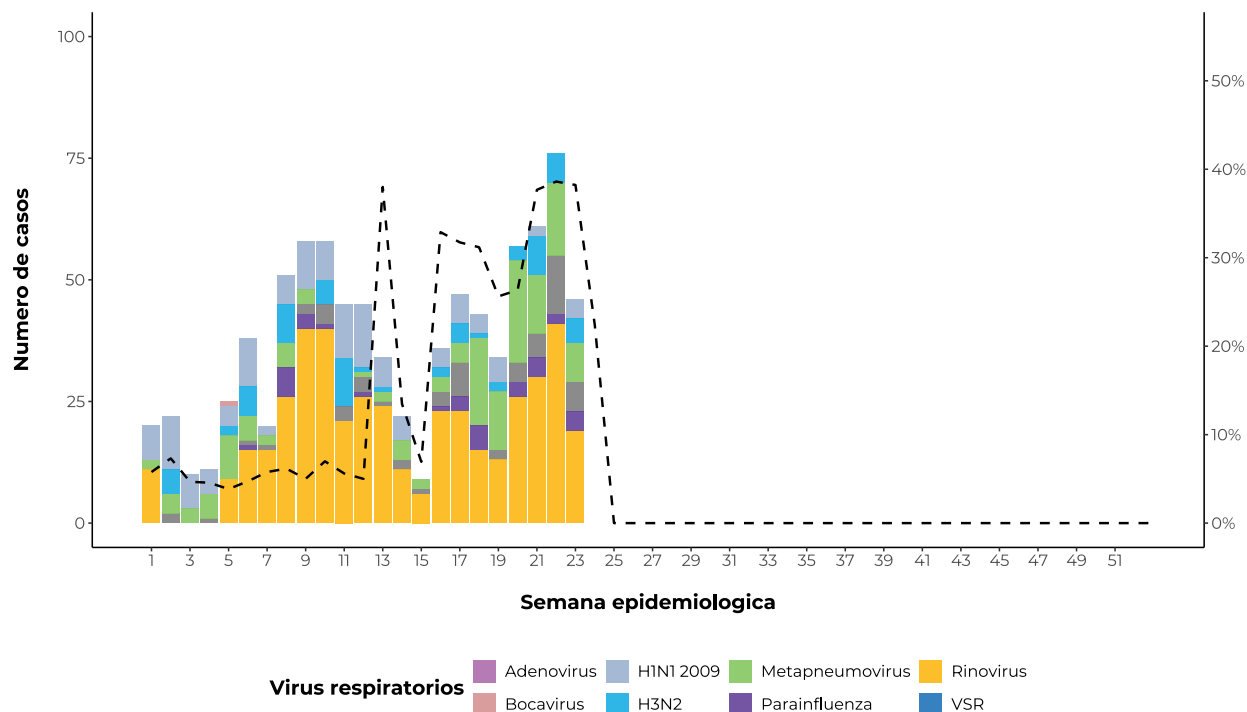
Tabla 6: Positividad de virus respiratorios por semana epidemiológica, Bogotá 2024

Semana Epidemiologica	% Positivos
1	10.5

2	13.3
10	12.7
11	10.2
12	9.1
13	69.1
14	24.5
15	12.6
16	59.8
17	57.7
18	56.7
19	46.6
20	47.9
21	68.5
22	70.2
23	69.5

Dentro de la circulación viral acumulada predominan Adenovirus (2 %), Bocavirus (0 %), H1N1 (0.1 %) y H1N1 2009 (9.1 %) cada uno respectivamente en las 693 muestras positivas de las 11611 analizadas (figura 6).

Figura 5: Circulación de virus respiratorios en casos de IRAG identificados por por panel respiratorio Allplex y prueba molecular, Laboratorio de Salud Pública.



En la semana 23 la circulación viral estuvo con predominio de Rinovirus (31.9 %), Otros Virus (18.1 %) y Parainfluenza (11.7 %); en las 183 muestras analizadas para esta semana.

Dentro de la circulación viral acumulada a 23 al incluir el virus de SARS CoV 2 en la distribución de los virus respiratorios, se observa que predominan Rinovirus (41 %), Otros Virus (14.5 %) y H1N1 2009 (13.8 %) de las 1647 muestras positivas de las 12467 muestras analizadas (figura 7).

Figura 6: Proporción acumulada de los virus respiratorios, Laboratorio de Salud Pública

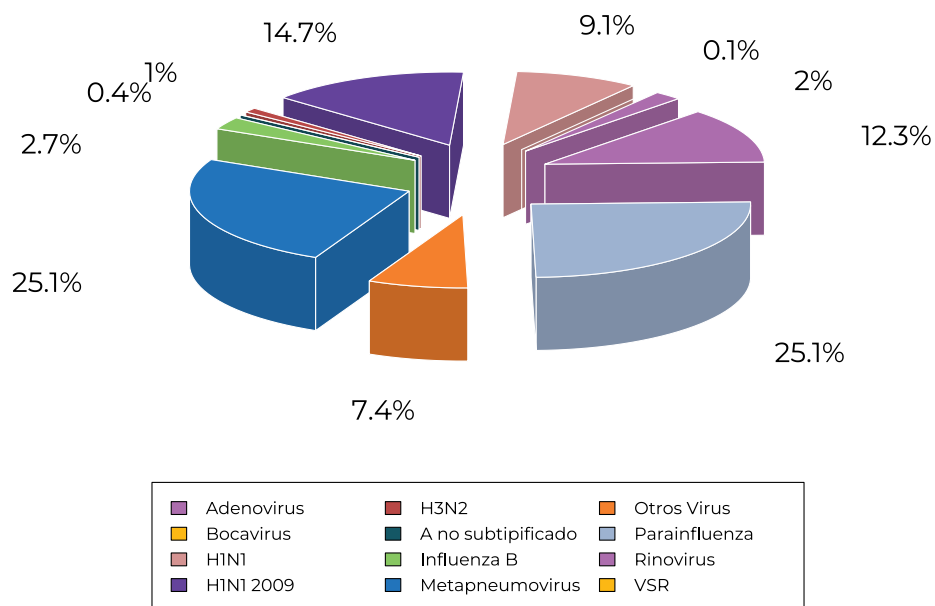
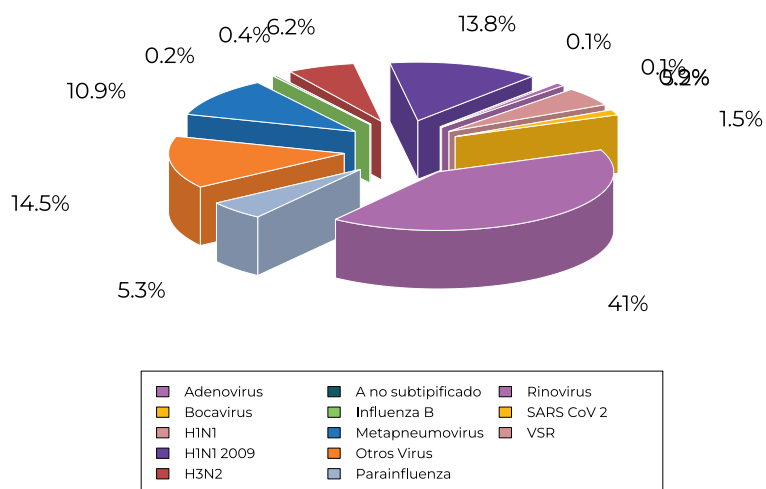
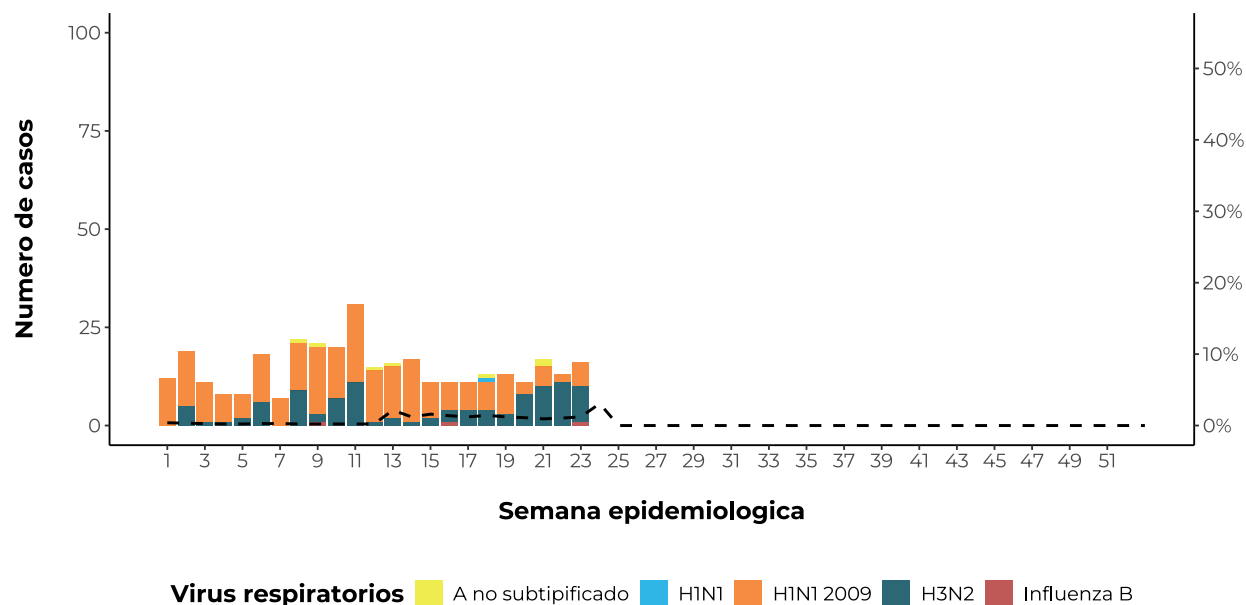


Figura 7: Proporción acumulada de los virus respiratorios, Laboratorio de Salud Pública



En cuanto al comportamiento de los virus de Influenza acumulado a SE 23 como de costumbre en las primeras semanas del año ha circulado el virus de H1N1 2009 (66.9 %), H3N2 (29.9 %), A no subtipificado (2.1 %), Influenza B (0.9 %) y H1N1 (0.3 %) en 341 muestras positivas. (Figura 8)

Figura 8: Distribución de tipos y subtipos de Influenza, Laboratorio de Salud Pública



2 Tosferina

El Laboratorio de Salud Pública también apoya la vigilancia de tosferina, con el análisis de todos los casos probables que se presenten en la ciudad. El análisis de la muestra se realiza mediante PCR Multiplex, que en tiempo real detecta *Bordetella pertussis*, *Bordetella parapertussis* y *Bordetella holmesii*.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SALUD

